

01 - 01- Les Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) - Pr. ADALI

Bonjour chers étudiants, c'est avec plaisir que je vous retrouve cette année pour les cours de santé mentale. Je suis Imen Adeli, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Aujourd'hui, on va traiter le cours des troubles des conduites alimentaires ou TCA.

A la fin de ce cours, vous devez être capable de définir l'anorexie mentale, définir la crise de boulimie, expliquer l'intérêt de l'examen clinique et du bilan somatique dans les TCA, reconnaître l'urgence vitale dans l'anorexie mentale, qui est une forme de TCA, citer les autres étiologies de la restriction alimentaire et planifier une prise en charge multidisciplinaire. Quelles sont les caractéristiques communes au TCA ? D'abord, l'alimentation est quantitativement et qualitativement distincte de ce que l'on rencontre habituellement chez des individus du même âge et de la même culture. Deuxièmement, les TCA ne sont pas secondaires à un autre diagnostic, tel que la dépression.

Troisièmement, on note un retentissement négatif sur la santé physique et mentale de l'individu concerné. Quatrièmement, ce comportement vient répondre à une problématique personnelle psychique qui n'a pas pu être gérée par d'autres moyens. Deux grands désordres sont décrits, boulimie et anorexie mentale.

Il faut noter que les TCA sont souvent diagnostiqués tardivement, puisque les études ont montré que seule la moitié des anorexiques seraient connues des services de soins, et les deux tiers des boulimiques ne seraient jamais prises en charge. La prévalence de l'anorexie mentale se situe entre 0,24 et 0,3 % selon les études. Celle de la boulimie est entre 1 et 1,5 % en population générale, prévalant sur la vie entière.

Les TCA sont une pathologie du sexe féminin, surtout en âge d'adolescence. Maintenant, on va détailler le chapitre de l'anorexie mentale. Cliniquement, il existe deux phases.

La phase de début est difficile à repérer précocement. Les premières consultations se font auprès du médecin de la famille ou le médecin généraliste. La demande de consultation émane surtout de la famille.

Elle concerne surtout la santé physique de l'adolescente. Elle ne veut plus manger. Elle a beaucoup maigri dernièrement.

Elle a une mauvaise mine. Cependant, la patiente est indifférente. Elle justifie son comportement.

C'est juste que j'ai un petit appétit. À noter la notion d'un régime alimentaire suite à une prise de poids minime au moment de la puberté. La phase d'état comporte la triade classique de l'anorexie mentale, ou les trois A. D'abord, le premier A, c'est l'anorexie.

L'anorexie est qualitative et quantitative, causée par une angoisse de prendre du poids et un désir de maigrir malgré le poids déjà inférieur à la normale. Les aliments sont sélectionnés en fonction de leurs valeurs énergétiques et des modes en matière de diététique, ainsi que des croyances. Par exemple, les aliments crus donnent l'impression d'être plus naturels et ne font pas grossir.

On note aussi une lutte active contre la sensation de faim, qui est source de honte et de culpabilité pour les patients. Le deuxième A, c'est l'amaigrissement. L'amaigrissement est constant et souvent rapidement important.

On note une diminution de 30 à 40 % du poids initial, menaçant ainsi même la vie de la patiente. Le troisième A, c'est l'aménorrhée. Elle peut être expliquée par les effets de dénutrition et de l'hyperactivité physique sur l'axe hypothalamohypophysaire.

La sexualité serait comme mise entre parenthèses. La patiente évite tout désir ou tout engagement affectif pouvant entraîner l'incertitude et le risque de séparation. D'autres symptômes sont associés à la triade classique de l'anorexie mentale.

Les comportements et rituels visant à réduire l'anxiété face à la prise alimentaire. Notamment la pesée minutieuse des portions alimentaires, le tri des aliments dans l'assiette, le fractionnement des repas en portions très petites et autres. On note aussi l'hyperactivité physique, le changement de l'humeur et du comportement et la présence de comportements de contrôle de poids, notamment les vomissements provoqués et l'abus de laxatif.

Je mets à votre disposition les critères DSM-5 de l'anorexie mentale qui résument le chapitre clinique. Après la clinique, on peut déduire le retentissement somatique de l'anorexie mentale. En effet, les complications médicales sont secondaires à la perte de poids, aux restrictions alimentaires ou aux comportements de contrôle de poids, notamment l'abus de laxatif et les vomissements provoqués.

Dans 50% des cas, la mortalité est liée à une complication somatique. A l'examen clinique, on note une faiblesse musculaire, des peaux sèches et ridées, ongles cassants, secs, bradythermie, bradycardie, hypotension, affaiblissement du système immunitaire ainsi que des troubles cognitifs, notamment un ralentissement du cours de la pensée, une diminution des capacités d'attention et de mémorisation. Les examens complémentaires ont pour objectif de apprécier le retentissement de la dénutrition, mettre en évidence les signes de gravité pouvant mettre en jeu le pronostic vital et les troubles de la croissance chez les patients prépubères.

Devant toute anorexie mentale, le médecin doit connaître les examens cliniques et paracliniques à faire pour éliminer l'urgence vitale et apprécier le retentissement somatique, notamment un examen clinique complet, calcul de l'IMC, l'évaluation du stade pubertaire, la NFS, la glycémie, un bilan hépatique rénal, un ECG et autres. L'anorexie mentale peut être masculine aussi, où la

perte de la graisse est remplacée par le développement des muscles, par la prise d'un abusant. Elle se voit chez certains sportifs, notamment des danseurs, des marathoniens, des jockeys.

Les troubles de l'érection et l'absence de libido sont considérés comme des équivalents de l'aménorrhée. L'anorexie mentale peut se voir aussi en âge adulte, après l'âge de 25 ans. Elle constitue un mode d'adaptation pathologique face aux difficultés rencontrées.

Dans l'anorexie prépubère, il y a un retentissement sur la croissance par un retard staturopondéral et des carences nombreuses. Il y a aussi des perturbations gynécologiques et une ostéoporose. L'anorexie peut être associée également à la bullying.

Devant l'anorexie mentale, il faut éliminer une pathologie organique, notamment une tuberculose, une maladie de Crohn, une tumeur cérébrale et autres. Il faut penser à une origine psychiatrique devant tout état délirant associé à une anorexie ou état dépressif avec amégrissement et perte de l'appétit. Le deuxième grand chapitre des TCA est la boulimie.

La boulimie se caractérise cliniquement par ce qu'on appelle la crise boulimique. Elle est définie par la consommation de grandes quantités d'aliments, ingérées de façon impulsive et irrésistible, et s'accompagnant d'un sentiment de perte de contrôle. En effet, la crise boulimique peut être déclenchée par une situation stressante, elle est précédée par une sensation de faim oppressante, un sentiment de perte de contrôle et une lutte intense contre l'arrivée d'une crise.

Elles dureront en moyenne une à deux heures, en continu et en cachette de l'entourage. Elles ont généralement fin de journée. Les aliments consommés sont souvent stockés en prévision de la crise.

Elles s'enrichissent en calories, gras ou sucrés. La fin de la crise survient lorsqu'il n'y a plus de nourriture ou quand la sensation de malaise physique devient trop intense. La crise est suivie de vomissements, provoqués dans un premier temps, qui deviennent ensuite quasiment spontanés.

La fin de la crise est associée à un sentiment de culpabilité, de honte et à un malaise physique. Le deuxième symptôme est le recours aux moyens de contrôle de poids, notamment la restriction alimentaire, l'excès d'exercices physiques, la prise de laxatifs ou de diurétiques. Je mets à votre disposition les critères DSM-5 de la boulimie.

Lors de la boulimie, les principales causes des complications somatiques sont liées aux d'abord les vomissements répétés, qui peuvent donner des troubles hydroélectrolytiques, une arythmie, des ulcérations de l'œsophage et autres, et à l'abus de laxatifs, qui peut donner une déshydratation, des troubles hydroélectrolytiques, des douleurs abdominales et autres. Ce tableau résume les principales complications spécifiques aux vomissements provoqués et le bilan clinique ou paraclinique à réaliser. Les diagnostics différentiels de la boulimie sont d'abord la dépression saisonnière, où on note une envie importante d'absorber des sucreries en quantité inhabituelle.

Deuxième diagnostic, la dépression majeure, avec crise d'hyperphagie, mais sans noter de comportement compensatoire. Troisième diagnostic est la gourmandise, toujours associée à la notion de plaisir, tandis que la boulimie engendre une souffrance intense. Quant au grignotage, l'ingestion répétée de petites quantités d'aliments en dehors des repas, sans répondre à une sensation de faim.

La troisième entité des TCA apparue récemment dans le DSM-5 est l'hyperphagie boulimique. Dans l'hyperphagie boulimique, les éléments sémiologiques les plus importants sont la prise alimentaire importante associée à une sensation de remplissage. C'est ce qu'on appelle la phrénésie alimentaire.

La perte de contrôle de l'acte alimentaire associée à l'absence de comportement de compensation, notamment pas de vomissement, pas de prise de laxatif. Un surpoids flagrant et des préoccupations pour la nourriture et le poids, avec des tentatives vaines de restrictions alimentaires en adoptant des régimes alimentaires draconiens. L'éthiopathogénie des TCA est encore mal connue.

Il existe en effet une intrication de plusieurs facteurs. D'abord, le modèle neurobiologique et génétique. Les études d'agrégation familiale des troubles du comportement alimentaire ont montré un risque de 3% d'avoir un enfant anorexique, si un apparenté de sexe féminin a le trouble, et un risque de 0,3% si ce n'est pas le cas.

Une altération du système sérotoninergique contribuerait aux troubles de la régulation de l'appétit. Les facteurs environnementaux incriminés sont les événements de vie stressants, notamment les séparations parentales, la perte d'un proche, le déménagement ou autre. L'importance du modèle culturel occidental actuel où un corps désirable n'est plus un corps en bonne santé, mais un corps mince voire maigre, dont le poids et les formes sont maintenus sous contrôle.

Certains milieux professionnels s'en disent à risque de développer les TCA, notamment les milieux de mode, de la danse, certains milieux sportifs comme celui de l'équitation ou de la gymnastique. Pour les facteurs psychologiques, pour l'anorexique, l'objectif principal semble être la capacité de contrôle. Les patientes anorexiques développent un sentiment de fierté grâce à leur comportement.

Chez les boulimiques, la minceur représenterait une manière d'améliorer l'estime de soi et le bien-être psychologique. On dit que le rêve des boulimiques serait de parvenir à se conduire comme des anorexiques et que pour les anorexiques, la plus grande hantise est de succomber à une crise de boulimie. Ce schéma montre l'intrication de plusieurs facteurs dans l'anorexie mentale.

C'est un résumé des facteurs éthiopathogéniques dans les TCA. L'évolution des TCA se fait vers

la chronicité chez 15 à 25 % des anorexiques, les comorbidités psychiatriques avec les troubles anxio-dépressifs et addictions, des complications somatiques intercurrentes, des difficultés relationnelles, de l'isolement et enfin un passage à l'acte suicidaire. La précocité d'un traitement adapté constitue un élément important du pronostic, ce qui nous renvoie au chapitre prise en charge.

D'abord, la prise en charge des TCA nécessite une coordination entre somaticien et psychiatre. Le psychiatre intervient dans la prise en charge par les psychothérapies, les thérapies corporelles, le traitement médicamenteux et le médecin somaticien, que ce soit un médecin généraliste, un nutritionniste ou endocrinologue, assure la surveillance de l'état physique du patient. On va commencer tout d'abord par le traitement de l'anorexie mentale.

La prise en charge somatique vise la restructuration du poids et la récupération d'un bon état de santé physique. Il n'y a aucun travail psychologique qui est possible et efficace sans restauration pondérale minimale, d'où la notion de contrat thérapeutique qu'on va voir après. Aucun traitement médicamenteux n'a fait la preuve de son efficacité dans le traitement de l'anorexie mentale.

L'hospitalisation dans l'anorexie mentale a pour objectif de reprendre le poids contractualisé avec l'équipe intra-hospitalière, c'est-à-dire pas de visite, pas de sortie avant l'atteinte de l'objectif de prise de poids, ou un apaisement des symptômes associés tels que l'hyperactivité ou les rituels obsessionnels. L'hospitalisation aux urgences se fait en cas d'urgence somatique. Ce tableau résume les critères somatiques de gravité indiquant une hospitalisation au service de médecine ou en pédiatrie, notamment un IMC inférieur à 13, une aphagie totale, des signes d'épuisement physique, bradycardie, hypocaliémie et autres.

Le troisième volet est l'hospitalisation pour une urgence psychiatrique en cas de passage à l'acte auto-agressif, soit par des tentatives de suicide ou de l'automutilation. Contrairement à l'anorexie mentale, le traitement de la boulimie se fait souvent en ambulatoire. Il cible les crises de la boulimie et les comportements associés.

Les thérapies cognitives et comportementales sont très efficaces, corrigent les pensées erronées concernant l'alimentation et l'image de soi et améliorent l'estime de soi. Les antidépresseurs de type inhibiteur de la recapture de la sérotonine trouvent leur intérêt dans la réduction de la fréquence des crises. Les hospitalisations en cas de boulimie se font si échec d'un traitement ambulatoire bien conduit, si conséquence physique des conduites de purge, et dans les cas sévères avec symptomatologie dépressive majeure avec ou sans risque suicidaire.

Dans les TCA, les thérapies corporelles sont indiquées chez ces patients, dont la souffrance psychique s'inscrit dans le corps. Elles se font en individuels ou en groupes, comportent relaxation, massage, ou autres approches sensorielles telles la musicothérapie. En conclusion, les TCA représentent un véritable problème de santé publique.

Ils seraient en progression dans les sociétés industrialisées. On doit souligner la fréquence du

manque de formation ou d'information des professionnels de santé qui méconnaissent souvent ces troubles et leur gravité potentielle. Je vous remercie pour votre attention.